Relación Basada a la Confianza®

CAPACITACIÓN 14 DE AGOSTO DE 2020 A 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020



PRINCIPIOS DE CORRECCIÓN DE TBRI®

LIBRO DE TRABAJO DEL PARTICIPANTE



KARYN PURVIS INSTITUTE of CHILD DEVELOPMENT
EST. 2005

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.



Instituto de Desarrollo Infantil
Karyn Purvis

TCU Box 298921
Fort Worth, TX 76129

child.tcu.edu

817-257-7415

2901 W. Lowden
Rees-Jones Hall #314
Fort Worth, TX 76109

TRUST-BASED RELATIONAL INTERVENTION®

CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADOR

PRINCIPIOS DE CORRECCIÓN DE TBRI®

LIBRO DE TRABAJO DEL PARTICIPANTE

Derecho de autor 2013
Revisado en 2017

TBRI® ha sido desarrollada por la
Dra. Karyn Purvis y el Dr. David Cross

Este libro de trabajo fue preparado por la
Dra. Jamie Hurst DeLuna

Este recurso de capacitación ha sido posible gracias a las fundaciones
Rees-Jones Foundation y Lesley Family Foundation

THE Rees-Jones FOUNDATION

Para citar este recurso: Purvis, K., Cross, D. R. y Hurst, J. R. (2013). *Trust-Based Relational Intervention® Caregiver Training: TBRI® Correcting Principles* (Libro de trabajo del participante). Fort Worth, TX: Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Una guía para este libro de trabajo

Bienvenido a la capacitación para el cuidador en Trust-Based Relational Intervention® (Intervención Relacional Basada en la Confianza) o TBRI® del Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis: Principios de Corrección. Esta capacitación está diseñada para ayudar a los participantes a aprender habilidades que pueden ser usadas para manejar el comportamiento de sus niños. Las actividades están estructuradas de manera tal que invitan a los participantes a observar varios episodios de mal comportamiento inadecuados a través de una "Lente de TBRI®".
En este libro de trabajo encontrará muchas ayudas para asistirlo durante la capacitación. Durante la mayoría de las secciones, su instructor lo dirigirá en una actividad para que usted tenga un componente experimental en su capacitación. En el libro de trabajo, encontrará espacios para anotar ejemplos de cómo los principios aplican a su propia vida y secciones donde puede tomar notas por su cuenta. Además, notará cuadros de textos con algunas de las siguientes frases: "Preguntas para reflexionar", "Aplique lo que ve" y "Piense de manera crítica", seguidos por algunas preguntas. Estos están diseñados para fomentar el debate dentro de su grupo de capacitación. Esperamos que comparta sus pensamientos, preguntas y sus propias historias sobre los temas que está aprendiendo.

Apego seguro – Preguntas para reflexionar:

1. ¿Qué tipo de historia piensa que esta niña y su madre tienen juntas? ¿Cómo lo sabe?



Los cuadros de preguntas fomentan el debate

Si desea referencia para cualquiera de los hechos o si desea investigar sobre lo que ha leído, pregúntele a su instructor; este tiene una lista que les hemos proporcionado.

Le deseamos lo mejor a medida que comienza su travesía con los Principios de Corrección de TBRI®. Nuestra meta en este libro de trabajo es ayudarlo a comprender cómo los niños aprendieron "comportamientos de supervivencia" (luchar, huir, paralizarse) y cómo usted puede desarmar dichos comportamientos al enseñarles habilidades nuevas de adaptación para la vida.

Metas de esta capacitación:

- Sentar la base para comprender cómo equilibrar la estructura y el cuidado durante las interacciones con niños.
- Mejorar la comprensión de la *Respuesta IDEAL*© y los *Niveles de Respuesta*™ de *TBRI*®.
- Comunicar que, después de un episodio de comportamiento inadecuado, los niños deben:
  - Estar contentos (satisfechos con ser exitosos a nivel de comportamiento).
  - Sentirse conectados con sus cuidadores.
  - Haber cambiado el comportamiento.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Índice

Una guía para este libro de trabajo ***1***
Introducción ***3***
Estrategias proactivas de TBRI®: Equilibrio entre estructura y cuidado ***5***
Estilos de cuidados ***6***
El estilo de cuidado autoritativo. ***6***
El estilo de cuidado autoritario ***6***
El estilo de cuidado permisivo ***6***
El estilo de cuidado negligente ***6***
Estrategias proactivas de TBRI®: Aplicación ***8***
El grupo de cuidado ***9***
Parte 1: tres reglas para las relaciones ***9***
Parte 2: revisar ***10***
Parte 3: Curitas® ***11***
Parte 4: práctica de habilidades ***12***
Parte 5: alimentación ***13***
Parte 6: Cierre ***13***
Estrategias de respuesta de TBRI® – La Respuesta IDEAL© ***15***
Immediate (inmediata) ***16***
Direct (directa) ***16***
Efficient (eficiente) ***16***
Action-based (basada en acciones) ***16***
Leveled at the behavior, not the child (enfocada al comportamiento, no al niño) ***17***
Definir el estándar ***17***
Estrategias de respuesta de TBRI® – Niveles de Respuesta™ ***18***
Nivel 1: Interacción divertida ***19***
Nivel 2: Interacción estructurada ***20***
Nivel 3: Interacción para calmar ***21***
Nivel 4: Interacción para proteger ***22***
Principios de Corrección de TBRI®: Juntando las piezas ***24***
Notas del participante ***26***
Recursos ***28***

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Introducción a los Principios de Corrección de TBRI®

Hasta ahora se han entrelazado los Principios de Corrección de TBRI® a lo largo de la capacitación, y ahora analizaremos todos los conceptos con mayor profundidad y lo ayudaremos a comprender mejor cómo estos podrían funcionar en las vidas de los cuidadores y los niños.

Primero, hagamos una revisión rápida. Para cada pregunta a continuación, tómese primero algunos minutos para la reflexión personal. Luego, hable con las personas a su alrededor. Después, se le pedirá que comparta algunas de sus respuestas.

Analice su travesía actual:

1. ¿Qué va *bien* en su travesía con los niños a los que atiende?

   O BIEN

   ¿En qué maneras se siente *preparado* para cuidar a niños que vienen de situaciones difíciles?

2. ¿Qué es *complicado* en su travesía con los niños a los que atiende?

   O BIEN

   ¿Cuáles *miedos* tiene a medida que hace su travesía para atender a niños?

3. ¿Cuáles principios de TBRI® ha usado hasta ahora?

4. ¿Cuál es su *mayor necesidad* en este momento que hoy tenemos juntos?

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Principios de Corrección

Los Principios de *Corrección* son guías para cambiar el comportamiento, pero los Principios de *Conexión* son la base de las relaciones.

Si bien la meta subyacente de todo lo que hacemos con los niños es la conexión, la meta explícita de la corrección es *enseñar, orientar, entrenar y corregir*.

Las Estrategias *proactivas* están diseñadas para enseñar habilidades sociales y de comportamiento.

Las Estrategias de *respuesta* están diseñadas para ayudar a los cuidadores a manejar el comportamiento desafiante.

Principios de Corrección – *Preguntas para reflexionar*

1. Piense en un momento en que un niño bajo su cuidado se haya portado mal. ¿Cómo respondió usted? ¿Qué tan bien funcionó la respuesta para calmar la situación?

2. ¿Qué otras respuestas podría haber usado? ¿Piensa que habrían ayudado o empeorado la situación?

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Estrategias proactivas de TBRI®: equilibrio entre estructura y cuidado

Como ha aprendido, las Estrategias proactivas de TBRI® son maneras de crear comunicación y confianza con los niños cuando están tranquilos y alertas (ni somnolientos, ni hambrientos ni "gruñones"). Practicar estas estrategias a intervalos regulares los familiarizará con las maneras adecuadas para manejar situaciones difíciles y autorregularse cuando ocurra un incidente de mal comportamiento. Cuando a los niños se les dan herramientas para volverse socios en sus propios progresos de comportamiento, los cuidadores a menudo pueden reorientar los desafíos de comportamiento con solo algunas palabras clave.

Antes de revisar las estrategias proactivas específicas, exploremos un componente esencial para comprender las estrategias proactivas: equilibrar la estructura y el cuidado.

En todas las situaciones, pero en particular cuando se responde a un comportamiento desafiante, los cuidadores deben comprender cuándo guiar con estructura y cuándo hacerlo con cuidado. Piense en la estructura y el cuidado cada una como un pie; deben caminar juntos y seguirse el uno al otro a fin de mantener el equilibrio y no caerse. Es lo mismo cuando se interactúa con niños. Cuando los cuidadores guían con estructura o con cuidado, deben seguir una de inmediato con la otra, a fin de que haya equilibrio.

Comprender cómo equilibrar la estructura y el cuidado y cómo definir el estándar es crucial para el cambio de comportamiento en todos los niños, pero especialmente importante para aquellos que vienen de situaciones difíciles. ***Proporcionar estructura a los niños cuando necesitan cuidado, impide la confianza. Proporcionar cuidado cuando los niños necesitan estructura, impide el crecimiento.*** Algunos estilos de cuidados fallan al tener demasiada estructura y otros al tener demasiado cuidado. Exploremos diferentes estilos de cuidado, comenzando con uno que usa un equilibrio entre la estructura y el cuidado.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Estilos de cuidados

El estilo de cuidado autoritativo

Los cuidadores autoritativos:

- Equilibran la estructura y el *cuidado*.
- Proporcionan orientación y apoyo emocional.
- Establecen límites y tienen *expectativas* altas adecuadas.

El estilo de cuidado autoritario

Los cuidadores autoritarios:

- Valoran *la obediencia y el cumplimiento* por encima de todo.
- Son *punitivos* cuando los niños se comportan mal.
- Creen que los niños deben aceptar las visiones/reglas de los cuidadores como "correctas", sin preguntas.

El estilo de cuidado permisivo

Los cuidadores permisivos

- Son acogedores y comprensivos.
- Establecen pocos *límites*.
- Pocas veces corrigen el comportamiento del niño.

El estilo de cuidado negligente

Los cuidadores negligentes:

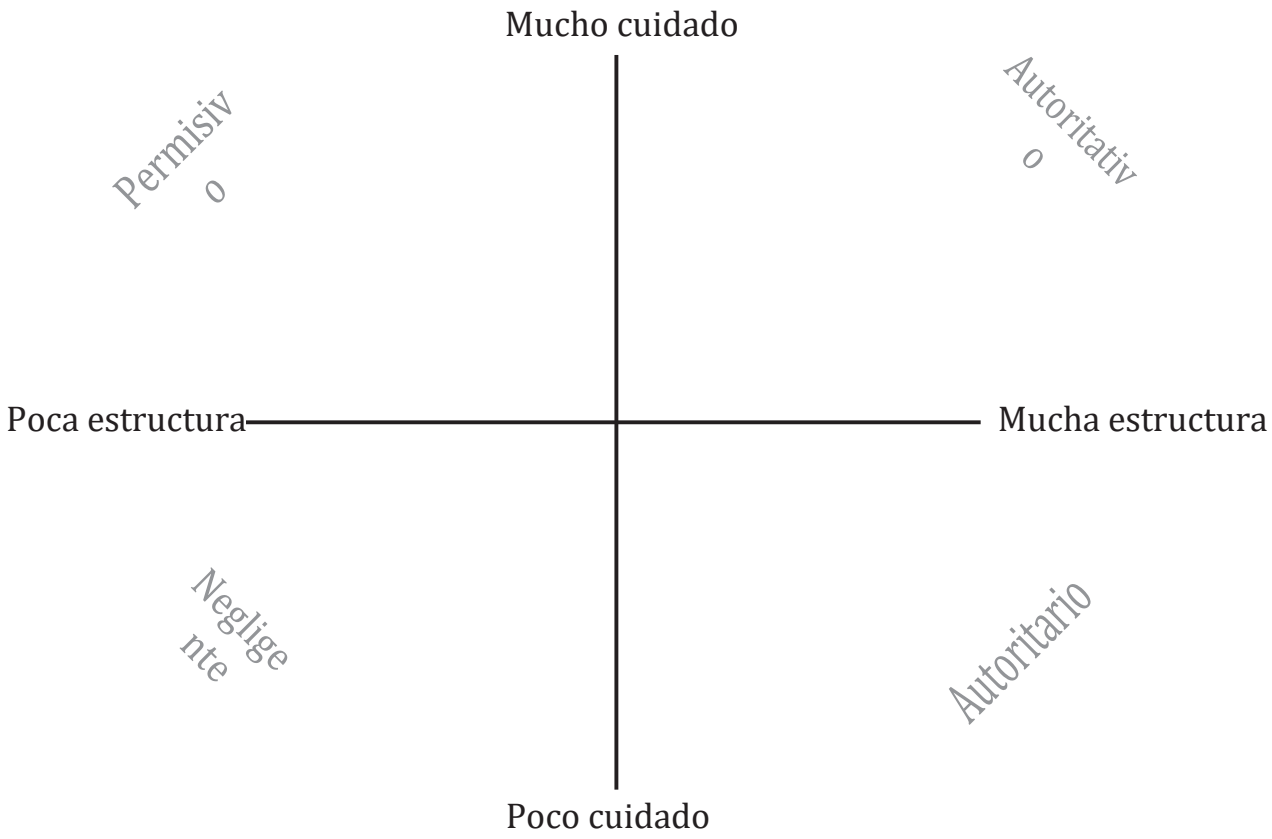
- A menudo rechazan a los niños.
- No se involucran con los niños.

Además,

- Los niños de hogares negligentes muestran más resultados *negativos* que los niños con otros estilos de cuidado.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Usando el gráfico a continuación, considere tanto la estructura como el cuidado y califique sus propios comportamientos en un día normal. Si actualmente no tiene niños bajo su cuidado, califique su comportamiento cuando está alrededor de niños o cómo piensa que será su comportamiento cuando tenga niños bajo su cuidado.



Una vez que haya calificado sus propios comportamientos en un día normal, haga otra calificación: su comportamiento cuando un niño bajo su cuidado presenta un comportamiento desafiante. De nuevo, si no tiene niños bajo su cuidado, califique la manera en que normalmente interactúa en situaciones desafiantes con otros niños O BIEN cómo piensa que actuaría en una situación de comportamiento desafiante.

Muchos participantes pueden hallar que sus comportamientos cambian entre la primera y la segunda calificación, y que fallan al tener demasiada estructura o demasiado cuidado. Parte de lograr el equilibrio entre la estructura y el cuidado implica simplemente tener conciencia de que se trata de un desafío. Es posible que recuerde haber aprendido sobre *la conciencia* en la capacitación sobre los Principios de Conexión de TBRI®. Ser *consciente* sobre dónde se pierde el equilibro (demasiada estructura o demasiado cuidado) y mantener esta conciencia puede ser útil cuando se interactúa con niños.

En la próxima sección, hablaremos sobre técnicas específicas que usted puede usar; es posible que recuerde algunas de la capacitación de Introducción y Resumen de TBRI®.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Estrategias proactivas de TBRI®: aplicación

La mejor manera de introducir y reforzar las *Estrategias proactivas de TBRI®* con niños es a través del juego. Incluso a los adolescentes les encanta jugar; solo se ve un poco diferente que con niños más pequeños. El juego es un momento de poca presión donde los cuidadores y los niños pueden relajarse y conectarse. Recuerde, la meta es la conexión, dado que la conexión constituye la base de una relación donde puede ocurrir el aprendizaje.

Cuando enseñe las *Estrategias proactivas de TBRI®*, escoja momentos donde los niños estén tranquilos y alerta. Intente encontrar un momento en que se hayan cubierto sus necesidades básicas (p. ej., están bien hidratados y han comido recientemente). A menudo, justo después de la actividad física funciona. El *grupo de cuidado* no es la única manera de enseñarles las *Estrategias proactivas de TBRI®* a los niños, pero ofrece ejemplos de cómo enseñar estas habilidades en la vida diaria.

En las capacitaciones previas, aprendió cuatro maneras de enseñar de manera proactiva habilidades sociales y de regulación a los niños:

- Compartir el poder
- Opciones
- Acuerdos
- Términos de valor para la vida

Estos tres conceptos pueden ser difíciles de implementar, pero cuando se usan de manera consistente, fortalecerán la conexión entre el adulto y el niño.

Estrategias proactivas *– Preguntas para reflexionar:*

1. ¿Qué va *bien* con el aspecto de compartir el poder y ofrecer opciones y compromisos?

   O BIEN

   ¿En qué maneras se siente *preparado* para usar las Estrategias proactivas de TBRI® una vez que tenga un niño bajo su cuidado?

2. ¿Qué podría hacer diferente en el futuro para aumentar el uso del poder compartido, las opciones y acuerdos?

   O BIEN

   ¿Qué piensa que podría ser *difícil* cuando use las Estrategias proactivas de TBRI® una vez que tenga un niño bajo su cuidado?

3. ¿Qué tipo de *apoyo* necesitará para usar de manera efectiva las Estrategias proactivas de TBRI® ?

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Grupo de cuidado

Si bien aquí demostramos estas habilidades como parte de una actividad grupal o reunión familiar, cada una de las estrategias ilustra el estilo de interacción divertida que se puede usar en todas las formas de la vida diaria. Por ejemplo, usar preguntas de revisar mientras espera en el carro o como parte de un ritual antes de ir a la cama.

Una manera de enseñar estas habilidades es a través de lo que llamamos *grupo de cuidado* (provenientes en gran medida de *Theraplay®* para Grupos). Este tiempo con el grupo implica varias actividades que les permiten a los niños practicar las *Estrategias proactivas de TBRI®* en el contexto del juego. El *grupo de cuidado* (que dura alrededor de 30-45 minutos) se puede usar como un momento de reunión con la comunidad una vez a la semana o incluso con más frecuencia. Los cuidadores pueden escoger una parte del *grupo de cuidado* para inculcar rutinas, o comenzar con una parte y agregar más con el tiempo.

Parte 1: tres reglas para las relaciones

Cada grupo comienza con las tres reglas de *Theraplay®* para Grupos, recordándoles a los niños que estas son reglas para escuelas, familias, organizaciones, amigos y amigas, etc. Las tres reglas son:

1. "¡Mantenerse juntos!"
2. "¡Sin lastimar!"
   - Las heridas pueden ser internas o *externas*.
3. "¡Divertirse!"

> ***Grupo de cuidado*** *– Preguntas para reflexionar:*
> ¿Cuáles *Estrategias proactivas de TBRI®* se practican durante las *reglas* del grupo de cuidado?

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Parte 2: revisar
La revisión ofrece una oportunidad para recibir atención especial mientras los demás "se mantienen juntos" y escuchan. También permite que los niños experimenten qué se siente tratar a los demás con respeto y ser respetados.

Durante la revisión, el líder del grupo realiza una pregunta al grupo (p. ej., "Si pudieses ser un animal, ¿cuál animal serías y por qué?") y cada miembro del grupo tomaría un turno para responder. A menudo, un artículo que funcione como una "pluma mágica" (p. ej., una bombilla intermitente, una bola de hilo, un micrófono, un animal de peluche) que sostenga la persona que hable, ayuda a atraer y mantener la atención de los participantes.

Ejemplos de preguntas de revisión incluyen:

- ¿Cuál es tu color favorito y por qué?
- ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás aburrido?
- Si pudieras ser un alimento, ¿cuál serías y por qué?
- ¿Cómo te sientes hoy?
- ¿Quién es una persona segura en tu vida?
- Otros ejemplos que se le ocurren:
  - _____
  - _____
  - _____

Grupo de cuidado *– Preguntas para reflexionar*
Cómo la *revisión* del grupo de cuidado les permite a los niños practicar:

1. Proporcionar cuidados

2. Recibir cuidados

3. Negociar necesidades

4. Ser autónomo

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Parte 3: Curitas®

Cuidarse entre sí con Curitas® les permite a los niños practicar el ser respetuosos para cuidar a otros. También les permite que otros cuiden de ellos. El líder del grupo (o cuidador) hace primero la demostración, al permitir que un compañero coloque una Band-Aid® en su herida y hacer una pequeña revelación de algo que le "duela" física o emocionalmente. A través de este ejemplo, los niños aprenden que es seguro usar palabras para decir la verdad y hablar sobre sentimientos. Las heridas pueden ser *externas*, tales como rasguños o moretones; pueden ser *internas*, tales como dolores de barriga o cabeza; o *emocionales*, tales como sentimientos de tristeza o ira.

Haga pasar una cesta llena con diferentes tipos de Curitas® que sean nuevas e interesantes, y permita que los niños y compañeros escojan una. Las alternativas a las Curitas® incluyen loción/talco sin aroma para colocar con palmaditas ligeras sobre la herida o tatuajes temporales. Usando el contacto visual y las palabras, los niños les preguntarán a sus compañeros si pueden colocar la Curita® que dicho compañero seleccionó sobre una de las heridas del mismo. El compañero puede aceptar o decir con buenas palabras (es decir, palabras respetuosas) "No, gracias".

Alternativas a las Curitas® que fomentan proporcionar y recibir cuidados:

- Aplicar loción/polvo sobre las manos de los demás.
- Hacerse tatuajes temporales entre sí.
- Mirarse entre sí y notar las manos del otro (p. ej., líneas, rasguños, etc.).
- Reconocer las heridas y decir "Lo siento que te duela".
- _____
- _____
- _____

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Parte 4: práctica de habilidades

Esta parte del *grupo de cuidado* se usa para enseñar y reforzar las habilidades sociales. Por ejemplo, al momento de enseñar la "autorregulación", podría enseñar una técnica de relajación. Involucre a los niños en una actividad que los desregule (p. ej., golpear globos, usar pistolas de agua o Silly String) y luego practique la regulación con las técnicas de relajación que aprendió en la capacitación de los Principios de Empoderamiento de TBRI®. Algunas técnicas de relajación incluyen:

- Respiración profunda
- Puntos de presión (sobre el labio y por encima y por debajo de los ojos)
- Flexiones/dominadas con la silla (mientras están sentados, empujar o halar la silla por diez segundos)
- Flexiones contra la pared (con los pies en posición de zancada, empujar contra la pared por diez segundos)

Otras actividades podrían incluir opciones y acuerdos. Cree una parodia usando marionetas o personas, con un "guion" de una situación en la cual sea posible que a los niños no les gusten las opciones que se les ofrezcan y ellos presenten un compromiso. Un ejemplo podría ser un niño que esté escogiendo cuál verdura comer en el almuerzo y pida un compromiso con respeto (p. ej., "Preferiría no comer zanahorias ni judías verdes. ¿Podría llegar a un acuerdo y comer pepino rebanado?").

Para los adolescentes, por lo general reducimos los guiones a frases de una a dos palabras, así que por ejemplo "Seamos amables y cordiales" podría convertirse en "Seamos amables".

¿Qué otras actividades se le ocurre?

- _____
- _____
- _____
- _____

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Parte 5: alimentación

Tomar turnos para alimentarse el uno al otro les ofrece a los niños la oportunidad para cuidar a alguien más y de recibir cuidado ellos mismos. Haga pasar un tazón de golosinas (los dulces pequeños funcionan y ayudan a conectar un acto de cuidado con algo dulce y placentero). A medida que cada persona reciba el tazón, hacen contacto visual con el compañero y le preguntan: "¿Puedo alimentarte?". El compañero puede aceptar o decir con buenas palabras "No, gracias" y alimentarse a sí mismo. Después de obtener el permiso, los niños practican cómo ser amables y cordiales a medida que colocan el dulce en la boca del compañero. Luego los niños y los compañeros cambian de rol.

Ideas para la alimentación:

- Dense de comer Gummy Lifesavers® entre sí usando pitillos.
- Dense de comer una papa frita/galleta e intenten hacer que crujan lo más fuerte posible.
- Dense de comer la merienda favorita del niño.

Parte 6: cierre

Cierre el grupo al repetir las tres reglas para las relaciones. Decir algo festivo como "Démonos un aplauso por ser tan geniales al (por ejemplo, practicar el respeto)" ayuda a los niños a sentirse exitosos y refuerza la cultura del juego.

Es de vital importancia que los momentos que se pasen en el *grupo de cuidado* estén cargados con:

- Interacciones *divertidas*
- Oportunidades para el *éxito*
- Repetición y aprendizaje de *habilidades*
- Celebración del tiempo juntos

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Metas de desarrollo

A continuación, verá un cuadro que describe varias metas de desarrollo para niños, conceptos y actividades que enseñan estas metas, y los resultados como adultos que se asocian con cada meta. Es importante recordar que, si bien podrían estar jugando a "ponerse al día", ¡ponerse al día es posible!

Meta de desarrollo	Principios y prácticas	*Estrategias de TBRI®*	Resultado como adulto (artículo de Jude Cassidy)
APEGO	Contacto visual Contacto seguro Voz prosódica Interacción divertida Alegría y risas	Crear juegos alegres Desarmar el miedo a través del juego Juegos de contacto como tatuajes temporales, Curitas®, masajes en los pies o las manos, masajes en los hombros y otras actividades alegres	*Capacidad para recibir cuidados*
CONFIANZA	Poder compartido Dar una voz Dar opciones Ofrecer acuerdos Crear predictibilidad Proporcionar transiciones	Alimentarse los unos a los otros Quedarse con las Band-Aid® preferidas para el cuidado Adultos que modelan la vulnerabilidad Crear oportunidades para decir "¡SÍ!" ¡Hacerle saber al niño que a usted le importa lo que ellos desean/sienten/necesitan!	*Capacidad para dar y recibir cuidado*
AUTOESTIMA	Disfrute Admiración/elogios Aliento Compartir el poder Corrección esclarecedora del comportamiento	Pasar tiempo haciendo las actividades preferidas Ser intencionado sobre el contacto visual y el contacto Crear rituales diarios para el momento especial Herramientas creativas para facilitar el "dar una voz"	*Ser autónomo*
AUTOEFICACIA	¡Dar una voz! Dar opciones Ofrecer acuerdos Prestar completa atención Compartir el poder	Crear oportunidades para decir "¡SÍ!" Prestar completa atención cuando el niño habla Respetar las diferentes opiniones Mantener una cubeta con goma de mascar y enseñarle al niño a pedir (diga que "¡SÍ!")	*Capacidad para negociar*
REGULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	*Guiones como:* "Escucha y obedece" "Amable y cariñoso" "Obedece la primera vez" "Mostrar respeto" "Con permiso y supervisión"	Jugar "Simón dice" Jugar "Luz roja/luz verde" Juegos de regulación (Juegos acuáticos y pistolas de agua) "Repeticiones de motor" Ejercicios de respiración profunda Prácticas de autorrelajación	*Ser autónomo y capacidad para negociar*
SALUD MENTAL	Enseñar habilidades de autorregulación Enseñar percepciones sobre los estados emocionales Proporcionar habilidades para lidiar con emociones Adultos que modelan sus emociones	Gráfica de sentimientos Historias compartidas Llevar un diario Los adultos deben modelar los sentimientos/emociones Los adultos modelan la autorrelajación/autorregulación	*Ser autónomo y capacidad para negociar*

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Estrategias de respuesta de TBRI®: la Respuesta IDEAL©

Probablemente recuerda de la Introducción y Resumen de TBRI® que la Respuesta IDEAL© y los Niveles de Respuesta™ proporcionan pautas estructuradas para ayudarlo a manejar los comportamientos desafiantes de los niños. Estas normas están diseñadas para asistirlo cuando ayude a los niños a producir comportamientos *correctos* en vez de cómo castigar los comportamientos incorrectos. De esta manera, incluso los episodios de comportamientos más desafiantes se convierten en experiencias de las que los niños aprenden y de los cuales se benefician.

Metas del cuidador

Al momento de manejar episodios de mal comportamiento, es importante recordar que hay tres metas al final:

1. **Que los cuidadores <u>mantengan</u> la conexión con los niños.**
2. **Que los niños y los adultos terminen el episodio sintiéndose *<u>contentos</u>*.**
3. **Que el episodio termine con un *<u>cambio de comportamiento</u>*.**



© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Qué es la Respuesta IDEAL©

Immediate (inmediata)

- Las respuestas inmediatas ocurren dentro de <u>3</u> segundos del comportamiento, porque el cerebro solo retiene información en la memoria a corto plazo por unos pocos segundos.
- Es por eso que cuando usted aborda rápido el comportamiento desafiante, los niños tienen mejor capacidad para <u>*aprender*</u> de la experiencia.
- ¿Puede pensar en otras ventajas de abordar el comportamiento *de inmediato*?
  - Hace que el comportamiento recupere el rumbo rápidamente
  - _____
  - _____
  - _____

Direct (directa)

- *Ponerse al nivel del niño* (p. ej., arrodillarse para que el adulto esté al nivel de la vista del niño, sentarse si el niño está sentado).
- *Use contacto gentil en el hombro o brazo* (nota: si el niño está demasiado abrumado, tocarlo podría agravar el comportamiento del niño. Use su criterio en tales situaciones).
- *Haga contacto visual con el niño.* Las investigaciones muestran que el contacto visual durante la interacción crea diferentes patrones neuroquímicos que en las interacciones sin este.

Efficient (eficiente)

- Usar más <u>*estructura*</u> de la necesaria en una situación puede llevar al niño a un ciclo peor de comportamiento, posiblemente incluso a niveles psicóticos.
- Identificar el Level of Response™ adecuado para una situación particular ayuda a garantizar que la respuesta del cuidador sea acorde a la intensidad de esa situación.
- Recuerde: la meta es "mantener el tren en marcha", o mantener a los niños comprometidos y con el comportamiento correcto.

Action-Based (basada en acciones)

- El aprendizaje activo y experimental crea nuevas conexiones en el cerebro.
- La acción ayuda a que los niños aprendan a un ritmo más rápido y un nivel más profundo.
- Maneras de ser activos cuando corregimos:
  - Repetición
  - <u>Pedirle al niño que "lo intente de nuevo" con respeto</u>
  -

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

- _____

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Leveled at the behavior, not the child (enfocada al comportamiento, no al niño)

- Para niños que vienen de situaciones difíciles, la *autoestima* es frágil.
- Los adultos deben ayudarlos a comprender que los comportamientos no son lo que los niños son; el comportamiento o mal comportamiento no los define.
- Ayude a los niños que vienen de situaciones difíciles a comprender que tienen un valor personal a pesar del comportamiento.

Definir el estándar

Llamamos "definir el estándar" al establecimiento de expectativas para el comportamiento de los niños. Esto lo ayuda a comprender cuánto puede esperar de manera razonable del comportamiento del niño. Cómo definir el estándar implica las siguientes consideraciones:

Historial de desarrollo del niño

- Los niños que han sido maltratados o abusados necesitarán un estándar *más bajo* hasta que se desarrolle una confianza amplia en la relación.
- Comprender el historial de un niño le dice al cuidador cuán *frágil* podría ser.
- Para algunos historiales, este estándar podría ser relativamente estable con el tiempo. Por ejemplo, un niño, cuya madre haya consumido alcohol o drogas durante el embarazo, siempre tendrá algunos problemas de autorregulación. Tener conocimiento de esto lo ayudará a comprender que el estándar nunca se podrá definir tan elevado como podría definirse para un niño sin problemas prenatales.

Historial reciente del niño

- ¿El niño ha comido recientemente?
- ¿El niño ha tenido actividad física reciente?
- ¿Alguien o algo en el ambiente actuó como un detonante emocional? (p. ej., detonantes sensoriales, ver a una persona que se parece a un agresor).
- El estándar puede cambiar de un día para otro o de una hora para otra. Por ejemplo, los niños que no hayan tenido una merienda o comida recientemente (2 horas previas) podrían necesitar que el estándar se defina un poco más bajo de lo normal, hasta que la glucemia se estabilice con una merienda.

Eleve el estándar solo lo suficiente para que los niños puedan tener éxito.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Niveles de Respuesta™ de TBRI®

Es importante ser *eficiente* cuando se maneja un mal comportamiento. Como aprendió en la última sección, usar más estructura de la necesaria para corregir el comportamiento puede llevar a los niños a un comportamiento peor (incluso a niveles que podrían parecer psicóticos). Sin embargo, saber qué tanto intervenir (sin intervenir demasiado) es complicado. Los Niveles de Respuesta™ de TBRI® están diseñados para ayudar a los cuidadores con este desafío.

Niveles de Respuesta™

Nivel	Actividad cerebral	Capacidad cognitiva	Capacidad de regulación	Tiempo para la resolución	Meta final
Nivel 1: **Interacción divertida** **Ejemplos: "Todo está bien" y luego el niño es descarado o exigente por poco tiempo**	Todo el cerebro está disponible para el aprendizaje y la conexión	La capacidad cognitiva está intacta y en funcionamiento	Capaz de autorregularse con apoyo mínimo *Enfoque del adulto:* ser alegre	60 segundos o menos	Dar una voz al enseñarle al niño a pedir las cosas de manera adecuada
Nivel 2: **Interacción estructurada** **Ejemplos: el niño está agitado levemente o el mal comportamiento se prolonga**	Todo el cerebro, pero tiende hacia la lucha, la huida o la paralización	La capacidad cognitiva se ve levemente perjudicada	Capaz de corregularse con apoyo moderado Enfoque del adulto: estructurar el proceso de pensamiento del	De 5 a 10 minutos o menos	Dar una voz al enseñarle a negociar las necesidades
Nivel 3: **Interacción para calmar** **Ejemplos: el niño corre riesgo de tener un episodio importante, está levemente agresivo o está en peligro**	Estado alerta que tiende hacia la lucha, la huida o la paralización	La capacidad cognitiva se deteriora a medida que aumenta la desregulación emocional	Capaz de corregularse con suficiente tiempo y apoyo Enfoque del adulto: regulación emocional	De 15 a 30 minutos o menos	Dar una voz al enseñarle a regularse y luego las palabras que describen lo que necesitaba
Nivel 4: **Interacción para proteger** **Ejemplos: amenaza de daño, peligro inminente o comportamiento fuera de control**	Estado de alarma y de lucha, huida o paralización Las regiones cognitivas no están disponibles	La capacidad cognitiva no está disponible dado que domina la desregulación emocional y del comportamiento	Necesita temporalmente regulación externa total, tiempo y apoyo *Enfoque del adulto:* regulación del comportamiento	De 30 a 60 minutos o menos	Dar una voz al observar al niño durante el episodio y luego preguntarle: "¿Qué necesitabas?" Guiar la comprensión de las necesidades y cómo lograr que se cubran de manera adecuada

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Nivel 1: Interacción divertida

Con la Interacción divertida, la meta es apagar una chispa antes de que se convierta en un incendio, por así decirlo. ¿Con qué tipos de comportamiento trabaja la Interacción divertida?

- Usar un tono descarado o palabras un poco irrespetuosas
- Ser insolente por poco tiempo
- Voltear los ojos (sin señales de sufrir una carga emocional)
- Hablar fuera de turno o interrumpir
- Tomar algo sin permiso
- Exigir algo, en lugar de pedirlo de buena manera

Puede ser difícil mantenerse alegre cuando los niños tienen comportamientos desafiantes. La Interacción divertida, cuando se usa de manera consistente, es exitosa para corregir alrededor de 80% de los malos comportamientos.

Las respuestas del Nivel 1: Interacción divertida deben tener un tono acogedor, volumen moderado y una cadencia rápida y divertida. Piense en este nivel como una "reorientación con una sonrisa".

¿En qué maneras podría usar la Interacción divertida?

- Responda de manera divertida: "¿Lo preguntas o lo dices?" cuando un niño pida algo.
- Diga de manera acogedora: "La respuesta es sí, ¡pero inténtalo de nuevo con respeto!" en respuesta a tonos irrespetuosos.
- _____
- _____

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Nivel 2: Interacción estructurada
Este nivel requiere un poco más de intervención y atención. El Nivel 2: Interacción estructurada
se puede usar, por ejemplo, para comportamientos como estos:

- El niño tiene un problema o desregulación continuos.
- El niño puede estar agitado levemente.
- El niño puede estar hiperactivo.

Respuestas del adulto:

- Los adultos deben dejar lo que están haciendo para abordar la situación.
- Usar opciones y acuerdos.
- Pedirle al niño que haga una repetición (repetir la infracción con comportamiento y palabras correctos y respetuosos).

Por ejemplo, digamos que usted le ofrece dos opciones de fruta a un niño para el almuerzo (manzanas o uvas) y el niño dice en un tono exigente: "¡Dame fresas!". Podría intentar primero el nivel 1: Interacción divertida diciendo algo como: "¡Espera amigo! ¿Lo preguntas o lo dices? Intentemos eso de nuevo con respeto". Después de escuchar esto, el niño lo ignora, se dirige al refrigerador y saca las fresas, exigiendo: "¡Pica estas!". En este punto, la situación se ha intensificado y requiere una respuesta del Nivel 2: Interacción estructurada. Podría abordar de manera gentil al niño, ponerse a su nivel, hacer contacto visual, y decir algo como:

**"Cariño, si estás pidiendo un acuerdo,
necesitas usar palabras buenas".**

Seguido de: **"Voy a ayudarte a obtener lo
que necesitas, pero tienes que usar
palabras buenas".**

Aquí, tuvo que detener la situación (p. ej., el almuerzo), pero rápidamente podrá lidiar con la infracción y regresar al estado divertido. Por ejemplo, cuando el niño le pida con respeto que pique las fresas, usted podría decir:

**"¡Por supuesto! ¡Veamos si podemos encontrar la fresa más grande de todas!
¿Piensas que hay una del tamaño de tu nariz?"**

Regrese siempre al Nivel 1: Interacción divertida

Nivel 2: Interacción estructurada *– Preguntas para reflexionar*
Piense en un momento en que un niño haya mantenido un comportamiento que ameritara el Nivel 2: Interacción estructurada. ¿Cómo respondió usted? ¿Qué podría haber hecho diferente?

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Nivel 3: Interacción para calmar

Cuando las situaciones se intensifican al punto en que los niños necesitan ayuda para regularse y calmarse (o los niveles 1 y 2 no han tenido éxito), las respuestas del Nivel 3: Interacción para calmar pueden ser las mejores. A este nivel, se puede suponer que los niños también necesitan ayuda para determinar sus necesidades en la situación y cómo lograr que las mismas se cubran de manera adecuada.

- No eche al niño (p. ej., tiempo fuera o enviar al niño a su habitación).
- *Acerque* al niño para que sepa que usted es el defensor que ayudará a cubrir sus necesidades.
- Use un tiempo de inclusión o un lugar "para reflexionar" o "tranquilo".

Dependiendo del estado emocional del niño, una repetición puede seguir de inmediato a la situación, o más adelante cuando el niño esté tranquilo, pero alerta.

Premisas del Nivel 3: Interacción para calmar

- El niño o joven está abrumado y es reactivo, sin poder autorregularse sin apoyo.
- Las viejas habilidades de supervivencia (lucha, huida, paralización) se activan y, sin apoyo para regularse, el deterioro del comportamiento continuará.
- Si bien en el tiempo fuera "clásico" el adulto coloca al niño en un lugar para este fin, la meta es orientar al niño o joven tan pronto como sea posible para desarrollar en conjunto un plan para la autorregulación y luego implementarlo con apoyo del adulto.

Elementos esenciales del Nivel 3: Interacción para calmar

- *Un adulto seguro que pueda ofrecer apoyo* (por ejemplo, pararse cerca mientras un niño pequeño "reflexiona").
- *Un lugar seguro que se escogió en conjunto en un buen momento, cuando el adulto estaba creando con el niño un plan de seguridad.*
- *Un plan fortalecedor (por ejemplo, una manta o artículo con peso, un artículo perfumado, música relajante, etc.).*
- *Creación de un "plan portátil" para usar en la escuela, en el auto y otros lugares.*

Ejemplos de implementación del Nivel 3: Interacción para calmar

- Por favor, siéntate aquí y piensa en lo que hiciste mal y cómo podrías hacerlo bien. Estaré cerca y cuando estés listo para hablar, di 'listo'" (un tiempo de inclusión clásico).
- Un padre que dice: "Hijo, los dos nos estamos frustrando bastante. ¿Podemos tomarnos un tiempo fuera y dar un paseo?".
- Un cuidador que dice: "Mi trabajo es mantenerte seguro y no parece que te sientas seguro ahora mismo, ¿qué podemos hacer para ayudarte a sentirte seguro?" (luego el adulto escucha atento cómo el joven dice que podría sentirse seguro e implementa el plan).
- El adulto le sugiere al niño: "¿Necesitas ir a tu lugar seguro ahora mismo?, ¿quieres regresar y decirme qué necesitas cuando puedas hacerlo?".

Recuerde, la situación debe terminar con el Nivel 1: Interacción divertida. Si bien puede ser difícil ver una luz divertida al final de este túnel, terminar con alegría refuerza la conexión con el niño.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Nivel 4: Interacción para proteger

Cuando los niños son un peligro inmediato para sí mismos u otros, se necesita una respuesta del Nivel 4: Interacción para proteger . Los cuidadores deben buscar capacitación formal en un tipo de intervención aceptada por sus estados u organizaciones. Los comportamientos que requieren el Nivel 4: Interacción para proteger , incluyen:

- El comportamiento se intensifica con rapidez
- Actos repentinos de agresión
- Amenaza de peligro/daño
- Comportamiento fuera de control
- Colapso del comportamiento

Recuerde, el episodio no ha terminado hasta que regrese al Nivel 1: Interacción divertida con un niño.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Recomendaciones de tono, volumen y cadencia para Niveles de Respuesta™ de TBRI®

	Tono	Volumen	Cadencia
Nivel 1: Interacción divertida	Acogedor	Moderado	Rápida, divertida
Nivel 2: Interacción estructurada	Bajo, firme, pero no severo	Moderado	Moderada/lenta
Nivel 3: Interacción para calmar	Firme	Intenso pero no elevado	Lenta
Nivel 4: : Interacción para proteger	Muy firme	Intenso pero no elevado	Muy lenta

Niveles de Respuesta™ de la Respuesta IDEAL©

- Inmediata
- Directa
- Eficiente
- Basada en acciones
- Enfocada al comportamiento, no al niño

- Nivel 1: Interacción divertida
- Nivel 2: Interacción estructurada
- Nivel 3: Interacción para calmar
- Nivel 4: Interacción para proteger

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

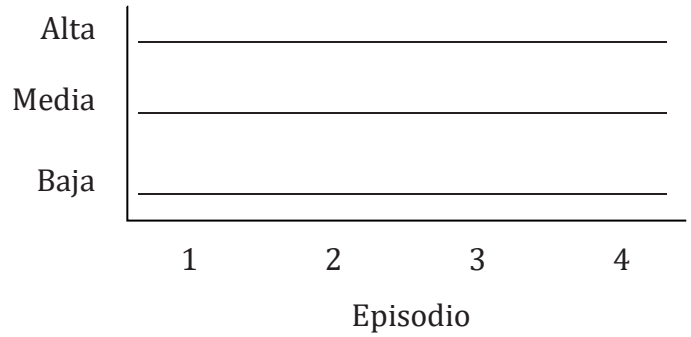
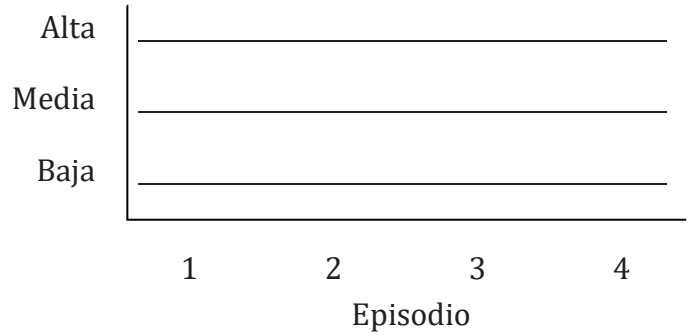
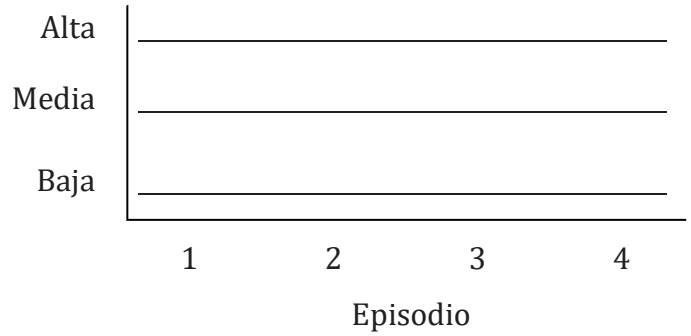
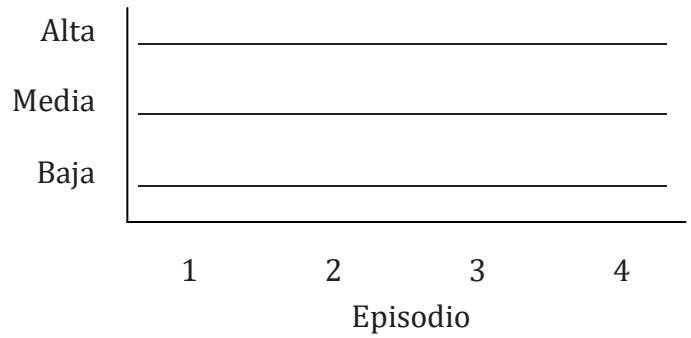
Principios de Corrección de TBRI®: juntando las piezas

Para esta actividad, mire el video sobre un episodio de mal comportamiento entre un niño y un adulto. Luego, escuche solo el audio del video. Note la modulación en el tono del adulto; el equilibrio entre estructura y cuidado se puede escuchar de principio a fin. Este equilibrio les permite al adulto y al niño mantenerse conectados a lo largo del episodio de mal comportamiento y el adulto aún ofrece una experiencia de aprendizaje para el niño. Ahora, vea el video desglosado en secciones y califique los siguientes comportamientos, al igual que lo hizo en los módulos de capacitación anteriores de TBRI®.

Lista de revisión de TBRI®	
Estrategias de TBRI®	**Notas**
<u>Principios de Empoderamiento</u> _____ Transiciones _____ Rituales (p. ej., ritual de apego) _____ Hidratación (agua) _____ Glucemia (meriendas) _____ Actividad física _____ Respiración profunda _____ Experiencias sensoriales: vestibular _____ Experiencias sensoriales: propioceptiva _____ Experiencias sensoriales: contacto	(*Sensación de seguridad*, nivel de autorregulación, nivel de desafío, etc. del niño – por episodio)
<u>Principios de Conexión</u> _____ Valorar el contacto visual _____ Voz autoritaria (tono, volumen, cadencia) _____ Contacto saludable _____ Emparejamiento comportamental _____ Interacción divertida _____ Conciencia: sintonización y conocimiento _____ Conciencia: presencia tranquila _____ Conciencia: resolución creativa de problemas _____ Conciencia: respuesta flexible	
<u>Principios de Corrección</u> _____ Términos de valor para la vida: usa tus palabras _____ Términos de valor para la vida: con respeto _____ Términos de valor para la vida: aceptar un "No" _____ Términos de valor para la vida: amabilidad y cariño _____ Términos de valor para la vida: escuchar y obedecer (1ª vez) _____ Guiones de comportamiento: opciones _____ Guiones de comportamiento: acuerdos _____ Guiones de comportamiento: repeticiones _____ Respuesta IDEAL©: inmediata _____ Respuesta IDEAL©: directa (comprometida - más arriba) _____ Respuesta IDEAL©: eficiente (niveles - más abajo) _____ Respuesta IDEAL©: basada en acciones (p. ej., repetición) _____ Respuesta IDEAL©: enfocada al comportamiento, no al niño _____ Niveles de Respuesta™: Interacción divertida _____ Niveles de Respuesta™: Interacción estructurada _____ Niveles de Respuesta™: Interacción para calmar _____ Niveles de Respuesta™: Interacción para proteger	

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Vea de nuevo el video y llene los cuatro gráficos a continuación. Los gráficos miden los indicadores globales de cómo la niña se siente a lo largo de la interacción y el nivel de desafío que le presenta al adulto. Para cada episodio, califique al niño de acuerdo con el título del gráfico (p. ej., califique la *sensación de seguridad* de cada niño durante cada episodio en el primer gráfico).

Estado	Calificación por episodio
Sensación de seguridad	
Auto-regulación	
Conexión	
¿Cuál es el estándar?	

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Notas

Recursos

www.child.tcu.edu
Sitio web para el Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis en la Universidad Cristiana de Texas

The Connected Child: Bring Hope and Healing to Your Adoptive Family (2007) de Karyn Purvis, David Cross y Wendy Sunshine
ISBN# 0071475001

www.empoweredtoconnect.org
Created to Connect, una guía de estudio gratuita y descargable. Artículos, ponencias en la web y consejos prácticos para padres que actualmente tienen niños en acogida temporal y adopción, o lo están considerando.

Trust-Based Parenting: Creating Lasting Changes in Your Child's Behavior (video)
Este video es parte de la serie de videos "Sanando familias" desarrollada por el Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis en la Universidad Cristiana de Texas. Disponible en DVD en www.child.tcu.edu o para descarga digital en www.icddigital.tcu.edu.

Empowering, Connecting, & Correcting Principles: Healing Children Through Trust and Relationships (video)
Parte de la serie de ponencias de la Dra. Karyn Purvis del Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis en la Universidad Cristiana de Texas, este DVD presenta los tres principios de TBRI®: Empoderamiento, Conexión y Corrección. Disponible en DVD en www.child.tcu.edu o para descarga digital en www.icddigital.tcu.edu.

Facilitating Behavioral Change (video)
Este DVD es parte de la serie de ponencias de la Dra. Karyn Purvis del Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis en la Universidad Cristiana de Texas. Ofrece experiencia y consejos prácticos sobre cómo usar los principios de TBRI® en situaciones de la vida real. Disponible en DVD en www.child.tcu.edu o para descarga digital en www.icddigital.tcu.edu.

The Happiest Toddler on the Block: The New Way to Stop Tantrums and Raise a Happy, Secure Child (DVD)
El Dr. Harvey Karp comparte métodos para ocuparse de los berrinches y colapsos emocionales de niños pequeños y ofrece estrategias a los padres para que superen los desafíos que presentan los niños de 2 a 4 años de edad.

The Happiest Toddler on the Block: How to Eliminate Tantrums and Raise a Patient, Respectful, and Cooperative One-to-Four-Year-Old: Edición revisada (libro) del Dr. Harvey Karp
ISBN# 0553384422
Brinda herramientas prácticas para los padres de niños pequeños.

The Successful Child: What Parents Can Do to Help Kids Turn out Well (libro) de William Sears, Martha Sears y Elizabeth Pantley
ISBN# 0316777498
Información práctica concerniente a el cuidado de niños seguros, compasivos y emocionalmente seguros.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.